

Université Constantine 3 Salah Boubenider
Faculté de médecine : Département de médecine
Annexes de la faculté de médecine : Oum El Bouaghi et Biskra
3^{ème} année médecine
1^{ère} Unité d'enseignement intégré
Cours de sémiologie

Plan du cours

I-Introduction

II-Rappel physiologique

III-Le poids normal : 1/ chez le nourrisson

2/ chez l'adulte

IV-Pathologie pondérale: 1/ obésité

2/ amaigrissement

Les objectifs

- * Définir les principaux paramètres pondéraux
- * Connaître les valeurs normales selon l'âge, le sexe et le contexte clinique
- * Identifier les principales anomalies: obésité et amaigrissement
- * Relier les anomalies pondérales aux grandes causes médicales

I. INTRODUCTION :

- Constante anthropométrique qui étudie le poids du corps et ses variations dans le temps
- Le poids est un indicateur essentiel sur l'état nutritionnel et du métabolisme
- Plusieurs causes entrent dans la modification du poids
- Elle constitue une étape de base de tout l'examen clinique, utile au diagnostic, au suivi thérapeutique et à la prévention

II. RAPPEL PHYSIOLOGIQUE :

Le corps est composé de :

1. - Le tissu de soutien : squelette, tissu conjonctif
2. - Le liquide extracellulaire
3. - La masse active ou masse maigre faite de muscles
4. - Le tissu adipeux ou masse grasse représentant 15 à 20 % du poids chez l'homme et 25 à 30 % chez la femme = il correspond aux réserves énergétiques

La somme de ces secteurs constitue le poids global.

Le poids peut être modifié par les variations de chacun de ces secteurs.

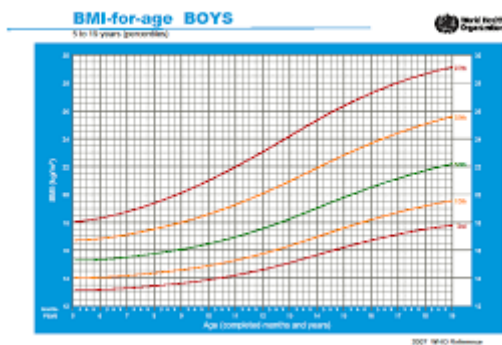
III. LE POIDS NORMAL:

- Le poids normal (poids idéal) est déterminé par rapport à la taille ; il est également fonction de l'âge, du sexe et de la corpulence (statut osseux).

1/ Chez le nourrisson et l'enfant :

- Le nouveau-né à terme perd généralement entre 5 et 8% de son poids de naissance au cours des premiers jours suivant l'accouchement, mais regagne son poids de naissance en moins de 2 semaines.

- Il prend ensuite 25 à 30 g/jour jusqu'à 3 mois, puis 4000 g entre 3 et 12 mois, double son poids de naissance à 5 mois, le triple à 12 mois et le quadruple presque à 2 ans.
- Entre l'âge de 2 ans et la puberté, la prise de poids est d'environ 2 kg/an
- Il existe des courbes de poids établies en fonction de la taille et de l'âge.



2/ Chez l'adulte :

Le poids normal = le poids idéal, il est déterminé selon la taille Son appréciation se fait selon les recommandations de l'OMS par le calcul de l'indice de masse corporelle = IMC

Comment mesurer le poids:

Patient déshabillé en sous-vêtements, vessie vide de préférence le matin à jeun. }
Peser : Poids (Kg) }

A- La classique formule de Lorentz : Poids (Kg) =

$$\frac{\text{Taille (cm)} - 100 - \frac{\text{Taille} - 150}{4} \text{ (chez l'homme)}}{\text{Taille (cm)} - 100 - \frac{\text{Taille} - 150}{2} \text{ (chez la femme)}}$$

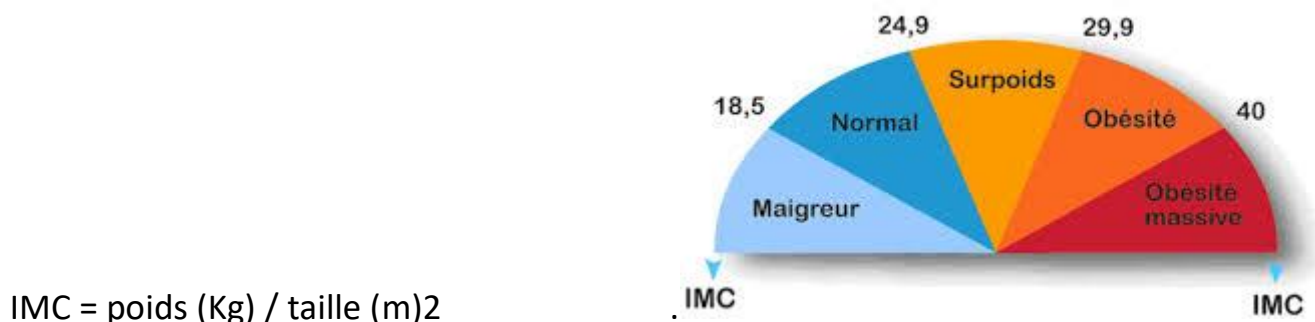
Remarque : Il faut ajouter 1 – 2 kg per décennie au-delà de 20 ans.

NB : n'est plus utilisée

B- Mesure du poids à partir de la taille : Le poids idéal correspond au nombre de centimètres au-dessus du mètre



C- L'indice de masse corporelle (IMC ou BMI) :



Comment mesurer son tour de taille ?

-Tour de Taille (TT) en cm : Reflète la répartition anatomique de la masse grasse permet d'évaluer les risques cardio-métaboliques même en l'absence d'obésité.

-La Haute Autorité de Santé a fixé des recommandations pour mesurer le tour de taille

*Se tenir debout, les pieds joints, les bras relâchés le long du corps

*Prendre un mètre-ruban et le faire passer à mi-distance entre la dernière côte palpable et la crête iliaque (l'os au niveau de la hanche).

*Mesurer le tour de taille en fin d'expiration (sans retenir la respiration évidemment).

*Ne pas prendre la mesure sur des vêtements épais ou amples.

H : TT > 100 à 102 cm	{ Normes Américaines }
F: TT > 88 à 90 cm	

H : TT > 94 cm	{ Normes Européennes }
F : > 80 cm	

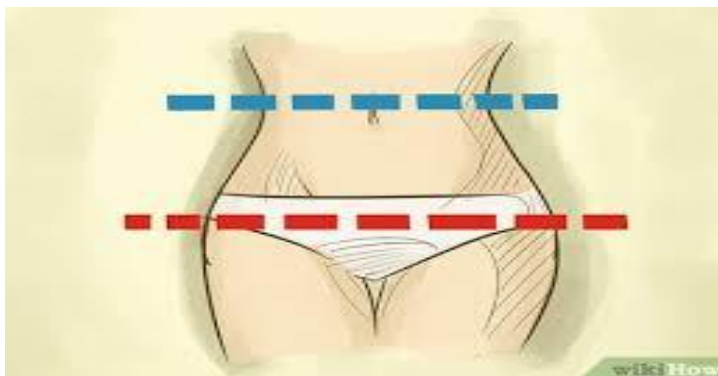
- La population Algérienne est à haut risque cardiovasculaire

Comment mesurer le Tour de hanche?:

-Positionner le mètre ruban bien à l'horizontal en passant par la circonférence la plus large au niveau trochantérien

-Ceci correspond à la partie la plus saillante de la fesse.

-Contrôler l'horizontale et Lire la mesure et la retranscrire



IV. PATHOLOGIE PONDERALE:

-La pathologie pondérale : Elle porte sur :

Les variations du secteur hydrique sont : - Une déshydratation, -
- Des œdèmes

Les variations de la masse grasse sont : - L'obésité
- L'amaigrissement

1/obésité:

- L'obésité se définit comme un excès de masse grasse entraînant des conséquences néfastes pour la santé. -
- Elle résulte d'un déséquilibre entre les apports et les dépenses d'énergie, aboutissant à une inflation des réserves adipeuses.
- Sa prévalence augmente avec l'âge, la prédominance est féminine.
- Elle doit être considérée comme une maladie car elle peut mettre en cause le bien être somatique, psychologique et social de l'individu.

Mais tout excès de poids n'est pas un excès de masse grasse, et la première étape clinique sera de distinguer un excès de masse musculaire et/ou osseuse ou une rétention d'eau liée à des œdèmes cardiaques ou veineux.

Sémiologie de l'obésité

L'interrogatoire ou anamnèse pondérale :

1. L'évolution pondérale :

noter : - le poids à la naissance , - le poids maximum, le poids minimum, - âge de début de prise de poids..

2. Les circonstances de prise de poids :

- a) Modification du statut hormonal : à la puberté, au cours de la grossesse, à la ménopause .
- b) Choc émotionnel ou affectif : (dépression et deuil).
- c) Changement d'environnement relationnel, familial (mariage, divorce, perte d'un emploi, arrêt de tabac, baisse ou arrêt de l'activité physique, une intervention chirurgicale, une prise médicamenteuse : corticoïdes, œstrogène, antidépresseurs)
- d) Pathologie endocrinienne : hypothyroïdie, cushing. Tumeur hypophysaire (trouble du sommeil, de la vigilance, hypogonadisme, troubles visuels..).

3. Noter les antécédents familiaux :

- d'obésité,
- de maladies métaboliques (diabète sucré, dyslipoprotéinémie)
- de pathologies vasculaires (HTA, IDM, Angor, artérite).
- Déterminer un arbre généalogique qui permettra d'évaluer les facteurs génétiques : lorsque les deux parents sont obèses, 60 à 80 % des enfants le sont et lorsqu'un seul parent est obèse, 40 % le sont.

4. Enquête alimentaire : préciser :

- la ration calorique alimentaire quotidienne
- Le comportement alimentaire : (grignotage, compulsions alimentaires, comportement de restriction, boulimie).

La boulimie est une crise d'hyperphagie échappant au contrôle du sujet qui consomme des quantités énormes de nourriture au-delà de toute satiété.

5. mode de vie:

- l'activité professionnelle,
- le type et l'intensité de l'activité physique pour estimer les dépenses énergétiques

6. Définir le profil psychologique :

1. Une évaluation psychologique est indispensable : existence ou non d'un retentissement psychologique de l'obésité

Examen clinique:

-Le poids et la taille (Il est à noter que certaines prises de poids ne sont pas liées à l'augmentation de la masse grasse (anasarque, augmentation de la masse musculaire des sportifs).

-les constantes hémodynamiques : TA, FC, FR, saturation, glycémie

-Rechercher des signes accompagnateurs :

* les vergetures : qui sont des stries plus ou moins longues et plus ou moins larges, blanchâtres ou rougeâtres siégeant au niveau de l'abdomen

* la cellulite : qui est un épaissement de la peau qui prend l'aspect de peau d'orange; elle siège essentiellement au niveau des hanches et des cuisses

Types d'obésité:

c'est à dire apprécier la répartition du tissu adipeux grâce à la détermination du tour de taille ou du rapport taille/hanche

Ces deux paramètres permettent de distinguer 3 types d'obésité :

1* Obésité androïde : obésité abdominale (qui est associée à des complications cardio-vasculaires et métaboliques) :

- quand le tour de taille > 90 cm, > 100 cm homme : la graisse prédomine à la partie haute du corps et sur l'abdomen Ou un RTH > 0,85 chez la femme, > 1 chez l'homme

2* Obésité gynoïde ou fémorale : la graisse prédomine à la partie basse du corps : bassin, hanche et membres inférieurs. Le RTH < 0,80 chez la femme, < 0,95 chez l'homme

3* Obésité mixte : adiposité globale. le RTH compris entre 0,80-0,85 chez la femme entre 0,95-1,00 chez l'homme.

Indice utilisé	Valeur	Classification
IMC	< 18,5 kg/m ²	Maigreux
	18,5-24,99 kg/m ²	Normal
	≥ 25 kg/m ²	Surpoids
	≥ 30 kg/m ²	Obèse
	30,0-34,9 kg/m ²	Classe 1
	35,0-39,9 kg/m ²	Classe 2 (obésité sévère)
	≥ 40,0 kg/m ²	Classe 3 (obésité morbide)
Tour de taille	≥ 80 cm (femmes)	Risque de complication métabolique élevé
	≥ 94 cm (hommes)	
	≥ 88 cm (femmes) ≥ 102 cm (hommes)	Risque de complication métabolique très élevé
Tour de taille/tour de hanches	≥ 0,85 (femmes) ≥ 0,90 (hommes)	Risque de complication métabolique très élevé

Les complications de l'obésité:

a) Les complications cardio-vasculaires :

- Insuffisance coronaire.
- Hypertension artérielle.
- Insuffisance cardiaque (favorisée par l'HTA).
- Accident vasculaire cérébral par thrombose cérébrale.
- Insuffisance veineuse des membres inférieurs avec apparition des varices.

b) Les complications respiratoires :

il existe au cours de l'obésité des altérations fonctionnelles respiratoires et des échanges gazeux :

- La baisse de la compliance thoracique et pulmonaire
- Un syndrome restrictif aboutissant à une insuffisance respiratoire chronique.
- Syndrome d'apnée du sommeil (arrêt de flux aérien pendant au moins 10 secondes plus de 5 fois par heure), hyper somnolence, ronflement, troubles psychiques, trouble de la mémoire et de l'attention, céphalées matinales

c) Complications rhumatologiques :

Troubles de la statique vertébrale par dorsalgie et lombalgie entraînant une sédentarité.

d) Complication métabolique et endocrinienne :

- Diabète sucré (80 % des diabétiques de type 2 sont obèses)
- Dyslipoprotéinémie. : hyperlipidémies avec augmentation du taux de cholestérol et des triglycérides.
- Hyper uricémie (goutte).
- Troubles du cycle chez la femme : (aménorrhée, dysménorrhée)

e) Autres complications :

- Pathologies hépatobiliaires : stéatose hépatique.
- Lésions dermatologiques : mycose des plis, hyper sudation, dermite ocre

2/L'amaigrissement

-l'amaigrissement est une perte de poids en rapport avec la diminution de la masse grasse active. Il s'agit d'un symptôme important d'un grand nombre de maladies.

-Elle est définie par un IMC < 18

- Il doit être différencié de la maigreur qui est une insuffisance pondérale non pathologique, en effet il s'agit d'un état :

- Constitutionnel
- Stable.
- Qui ne s'accompagne d'aucun trouble.

Sémiologie pondérale

L'interrogatoire:

recherche :

-La rapidité et l'importance quantitative de la perte de poids. (quelques semaines a quelques mois).

- Un symptôme associé important: la notion d'anorexie ou inappétence qui peut être responsable de l'amaigrissement, mais qui peut manquer.

- D'autres signes associés : troubles digestifs : nausée, vomissement, diarrhée, une asthénie.

Enquête alimentaire :

-Chercher à établir une relation entre la perte de poids et la réduction des apports énergétiques :

- préciser la notion d'appétit et d'anorexie. La persistance de l'appétit voire l'existence d'une hyperphagie, oriente vers une maigreur constitutionnelle ou une hyperthyroïdie.

-une pseudo-anorexie avec refus actif de se nourrir est en faveur d'une anorexie mentale.

L'examen clinique :

apprécier l'état du pannicule adipeux (en cas d'amaigrissement important la peau est flasque et paraît trop grande pour le corps : ceci est surtout visible au niveau des bras, des cuisses et de l'abdomen); ainsi que l'état des masses musculaires : au niveau des bras et des mollets

- des signes de carence vitaminiques.

Ses étiologies :

a- Amaigrissement des troubles du comportement alimentaire : - Anorexie mentale -
Boulimie

b- Amaigrissement avec alimentation conservée et hypercatabolisme :

* Amaigrissement des endocrinopathies et des maladies métaboliques :

- Diabète sucré de type1 (insulinodépendant)

- Hyperthyroïdie

- Insuffisance surrénalienne

- Insuffisance hypophysaire

- Phéochromocytome

* Amaigrissement du caféisme et tabagisme

* Amaigrissement des affections digestives

* Amaigrissement paraphysiologique avec l'âge.

c- Amaigrissement d'accompagnement : toutes les maladies viscérales peuvent être à
l'origine d'un amaigrissement :

* Amaigrissement des affections cancéreuses et non cancéreuses tel que les
malabsorptions digestives.

* Amaigrissement des syndromes infectieux : tuberculose, infection HIV (SIDA).

* Amaigrissement au cours des maladies inflammatoires.

d-iatrogène : biguanides

e- Amaigrissement isolés 20% des cas : psychogène ou indéterminé

LA CONCLUSION

- Les variations pondérales doivent toujours être corrélées au contexte clinique
- Une perte de poids involontaire est toujours pathologique jusqu'à preuve du contraire et nécessite une investigation étiologique rigoureuse
- Une prise de poids peut révéler plusieurs étiologies

Dr Merzougui Al